

TEMA 3.40 • OBSTETRICIA

Rotura Prematura de Membranas (RPM)

PERFIL EUNACOM 3.01.2.014
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Rotura Prematura de Membranas (RPM)

Clínica

Pérdida de líquido amniótico por genitales (acuoso, olor a cloro).

Diagnóstico

Cualquiera confirma:

TABLA 3.40.1: EXAMEN VS HALLAZGO	
EXAMEN	HALLAZGO
Especuloscopia (1ª elección)	Líquido amniótico saliendo por OCE
Ecografía	Oligoamnios (si cede el chorreo)
PAMG-1 (PAN-1) e IGFBP-1	Proteínas específicas de LA — 1ª elección actual (alta sensibilidad/especificidad)
Test de cristalización	Arborización (menos específico)
Test de nitracina	pH ≥ 7 (LA es neutro)

NOTA CLÍNICA

Polihidramnios en eco → **descarta RPM** (muy raro tener RPM con exceso de líquido).
Diagnósticos diferenciales: incontinencia urinaria, tapón mucoso, leucorrea, hidrorrea decidual.

Manejo

TABLA 3.40.2: EG VS CONDUCTA	
EG	CONDUCTA
≥ 34 semanas	Interrumpir
< 34 semanas	Conducta expectante + corticoides antenatales + ATB

Interrupción (≥ 34 sem): ¿por qué vía?

TABLA 3.40.3: CONDICIÓN VS VÍA	
CONDICIÓN	VÍA
Índice de Bishop ≥ 7	Inducción con oxitocina
Índice de Bishop < 7	Inducción con misoprostol
Cesárea previa	Cesárea (misoprostol contraindicado)
Presentación podálica	Cesárea

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

RPM + trabajo de parto → NO tocolíticos (infección + contracción = alto riesgo).
RPM ≥ 18 horas → profilaxis ATB para SGB.
Cesárea previa → contraindicado misoprostol → cesárea.

Conducta expectante (< 34 sem)

- Corticoides antenatales (24–34 sem)
- ATB: **ampicilina + azitromicina**
- Monitorización materna y fetal

Casos Prácticos

TABLA 3.40.4: EG VS SITUACIÓN		
EG	SITUACIÓN	CONDUCTA
30 sem	RPM sin TP	Expectante + corticoides + ATB
~30 sem (sin control)	RPM, eco dice 30 sem (rango error 3 sem → 27-33)	Expectante, duda al interrumpir

| ~32 sem (sin control) | RPM, eco dice 32 sem (rango error → 29-35 sem) | **Amniocentesis** para test de madurez pulmonar → si maduro: interrumpir |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Rotura Prematura de Membranas (RPM), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Rotura Prematura de Membranas (RPM). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clínica
- Diagnóstico
- Manejo
- Interrupción (≥ 34 sem): ¿por qué vía?
- Conducta expectante (< 34 sem)
- Casos Prácticos
- (1ª elección) | Líquido amniótico saliendo por OCE | |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM))**PREGUNTA 1**

Respecto a Rotura Prematura de Membranas (RPM), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Rotura Prematura de Membranas (RPM) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Rotura Prematura de Membranas (RPM) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Rotura Prematura de Membranas (RPM) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Rotura Prematura de Membranas (RPM) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Rotura Prematura de Membranas (RPM) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Rotura Prematura de Membranas (RPM)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Rotura Prematura de Membranas (RPM). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM)

:::note Polihidramnios en eco → descarta RPM (muy raro tener RPM con exceso de líquido).